

Il Corpo Deformato — Disturbi del Comportamento Alimentare · Sintesi

Salute Mentale · Sessione 11

Il cibo non è mai solo cibo. È identità, relazione, controllo — e quando tutto questo va storto, nascono i disturbi del comportamento alimentare. Sessione densa ma importante, specialmente per il lavoro sul campo.

Il Cibo Come Simbolo e Relazione

- Il cibo è il primo mediatore della relazione madre-bambino: prefigura le relazioni future
 - Il gusto è costruito culturalmente (cervello, memoria, emozioni) — non è mai "neutro"
 - Il cibo è marcatore culturale e identitario (migranti, riti familiari, occasioni sociali)
 - Tendenza attuale: il pasto da momento di unione a **momento di divisione** — "tribù alimentari" (Niola, 2015): vegani, ortoressici, fitness-isti, ognuno con i propri tabù
-

Classificazione DSM-5-TR — DNA (Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione)

6 categorie principali:

Disturbo	Caratteristica chiave
Pica	Ingestione di non-alimenti (sassi, plastica) — infanzia

Disturbo	Caratteristica chiave
Disturbo da ruminazione	Rigurgito automatico del cibo — infanzia
Disturbo evitante/restrittivo	Alimentazione selettiva, fobia dei cibi nuovi
Anoressia nervosa	Restrizione + paura del peso + distorsione immagine corporea
Bulimia nervosa	Abbuffate + comportamenti compensatori
BED (Binge-Eating Disorder)	Abbuffate senza compensazione — riconosciuto nel DSM-5 solo nel 2013

- Quadri "puri" sempre meno frequenti → oggi prevalgono forme miste, oscillazioni e **sindromi sottosoglia**
- **Anoressia**: paura del peso, peso < minimo normale, immagine corporea distorta. **Nota: nelle prime fasi la fame c'è, serve grande sforzo per resistere**
- **Bulimia**: abbuffate + vomito (80% dei casi) o altri compensatori; autovalutazione influenzata dal peso. Polo dell'**impulsività** vs polo del **controllo** (AN)
- **BED**: abbuffate in solitudine con senso di colpa, senza compensazione sistematica

Evoluzione Storica del Sintomo (**Cosenza, 2008**)

1. **Anni '60** — "Mosche bianche": prime pazienti anoressiche, sintomo solo restrittivo
 2. **Anni '70** — "Malattia delle ragazze di buona famiglia" (**Bruch**): classe borghese, USA → Europa → Giappone
 3. **Anni '80-'90** — Compagno abbuffate e evacuazione; si diffonde anche alle classi popolari
 4. **Dal 2000** — Poliabuso + comorbidità; globalizzazione del sintomo; **siti pro-ana** → **identità costruita sul sintomo ("io sono ana")**
-

La Scissione Mente-Corpo

- **Selvini-Palazzoli** (1963): nell'anoressia la ragazza ha paura del **corpo**, non del cibo
 - Il corpo adolescente (pubere) diventa persecutorio, estraneo, "il nemico" — specialmente perché si avvicina al corpo della madre
 - **Funzione autarchica**: illusione di vivere senza apporti esterni = trionfo dello spirito sul corpo
 - I DCA rientrano tra le **patologie narcisistiche**
 - **Mito di Eco e Narciso**: impossibilità di comunicare + investimento narcisistico sul corpo
-

DCA Come Disturbi Etnici — La Cultura Plasma la Malattia

- **Devereux** (1978): ogni cultura ha propri disturbi etnici (*Culture-Bound Syndromes*)
 - **Esempi**: Amok (Malesia), Windigo (Canada), Cane Pazzo (Crow) — follie culturalmente codificate
 - I DCA rispettano i criteri: esagerazione di comportamenti considerati positivi, espressione di conflitti sociali, modello di "cattiva condotta" socialmente strutturato
 - **Concetto chiave**: la cultura non è la **causa** dei DCA — è un **fattore patoplastico** (Jaspers)
 - Non determina la malattia, ne plasma la **forma** espressiva
 - La stessa vulnerabilità psichica → isteria nell'800, disturbo alimentare oggi
-

Ortoressia e Vigoressia — I Nuovi Quadri

Ortoressia

- Ossessione per il "mangiare sano" — controllo sulla **qualità**, non sulla quantità
- Evita ristoranti, porta cibo da casa, guarda con disprezzo chi mangia diversamente
- Può estendersi a preoccupazioni ambientali/animaliste
- Non ancora nel DSM, ma in forte aumento
- **Rischio: intolleranze auto-diagnosticate da operatori non medici → diete sempre più restrittive**

Vigoressia (Muscle Dysmorphia)

- "Anoressia inversa" (Pope, 1993) — mai abbastanza muscolosi
- Dismorfismo corporeo speculare all'anoressia
- Prevalente nei maschi, si diffonde tra le adolescenti
- Dimagrimento come effetto secondario, non obiettivo

Confronto chiave AN vs Ortoressia/Vigoressia

- AN: obiettivo = dimagrimento, repulsione per il cibo, sottopeso
 - Ort/Vig: controllo = fine in sé, qualità non quantità, dispercezione non sempre presente
-

Eziologia Multifattoriale

- **Predisponenti**: genetica (perfezionismo, ossessività), personalità premorbosa, influenza familiare, pressione socioculturale
 - **Precipitanti**: eventi stressanti (lutto, trauma, fallimento scolastico, prese in giro)
 - **Cronicizzanti**: effetti del digiuno (spinta biologica al cibo), distorsione cognitiva, alterazioni fisiche (esofago, ossa, cuore), ruolo della famiglia
-

Aspetti Psicodinamici

- Difficoltà nel **processo di separazione-individuazione** (Mahler) come fattore di fondo
 - **Bruch**: "bambine perfette" con bisogni non riconosciuti → **falso sé compiacente**
 - La restrizione alimentare = "Sono io che decido cosa entra in me" → **illusione di autonomia**
 - Dialettica tra dipendenza e autonomia:
 - Abbuffata = ritrovare dipendenza
 - Vomito = cercare autonomia
 - Restrizione = illusione di bastare a sé stessi
 - **In un'epoca di identità liquida, il sintomo offre un'identità pronta (disfunzionale ma immediata)**
-

Per il Lavoro Sociale

- **Non gestire l'aspetto alimentare direttamente — spetta a medico/ nutrizionista/psicologo**
 - Costruire relazione di fiducia senza forzare sul tema del cibo
 - Lavorare sui temi affettivi e relazionali sottostanti
 - **Presa in carico multidisciplinare e coinvolgimento della famiglia sono fondamentali**
 - **Le ricadute fanno parte del processo — non prenderle come sconfitte**
-

Da ricordare: **Fattore patoplastico** (la cultura plasma la forma, non causa la malattia) · **Tre livelli eziologici** (predisponenti / precipitanti / cronicizzanti) · **Anoressia = controllo; Bulimia = perdita di controllo** — spesso facce della stessa medaglia